

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

DENGAN

PT.NAYAKA ERA HUSADA

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN

Nomor : 026.1/DPM/E-PKS/DIR/I/2025
Nomor : PKS/107/052025

Pada hari ini Selasa, tanggal 28 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PT. DISA PRIMA MEDIKA**, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sefrina Trisadi, Sp. Dv**, selaku direktur **PT. DISA PRIMA MEDIKA**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Banjararum Selatan Nomor 7 Mondoroko Kecamatan Singasari Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PT. NAYAKA ERA HUSADA**, dalam hal ini diwakili oleh **Apt. Sri Suntari, S.Si.**, selaku Branch Manager PT. Nayaka Era Husada berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor : KEP / 003 / 012022 tanggal 28 Januari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Nayaka Era Husada, berkedudukan dan berkantor di Jalan Ciujung No 4, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Telp. (0341) 477805 Fax. (0341) 402099 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

1. **PIHAK PERTAMA** adalah **PT.DISA PRIMA MEDIKA** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta No. 26 tanggal 27 Januari 2003 dibuat di hadapan Endang Merduwati,S.H, Notaris di Malang, yang membawahi 2 (dua) rumah sakit yaitu :
 - 1.1 Rumah Sakit Prima Husada yang beralamatkan di Banjararum Selatan No.3 Mondoroko Malang yang selanjutnya disebut dengan RSPH Malang;
 - 1.2 Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang beralamatkan di Jalan Raya Surabaya – Malang KM 54 Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut dengan RSPH Sukorejo.

			
---	--	--	--

Paraf **PIHAK PERTAMA**

Halaman 1 dari 23

			
---	---	---	---

Paraf **PIHAK KEDUA**

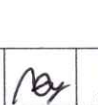
2. **PIHAK KEDUA** adalah **PT. NAYAKA ERA HUSADA**, dalam hal ini diwakili oleh **Apt. Sri Suntari, S.Si.**, selaku Branch Manager PT. Nayaka Era Husada, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ciujung No 4, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Telp. (0341) 477805 Fax. (0341) 402099 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nayaka Era Husada.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan dan Perawatan bagi pegawai dan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan beserta keluarganya & Peserta JPK PT. Nayaka Era Husada (**selanjutnya disebut PESERTA**) antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

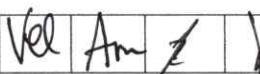
Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Perjanjian Kerja Sama** adalah perjanjian kerjasama yaitu naskah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan bagi peserta ini, beserta seluruh lampiran-lampiran dan perjanjian tambahan / perubahan (*addendum / amandemen*) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian selanjutnya disebut "Perjanjian";
2. **Rumah Sakit** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
3. **BPJS Kesehatan** (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia;
4. **Badan Penyelenggara Program JPK Nayaka** adalah PT. Nayaka Era Husada yang diberikan kepada peserta meliputi : Promosi Kesehatan, Pencegahan Penyakit, Penyembuhan dan Rehabilitasi Kesehatan serta fungsi organ tubuh yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan jaringan (*Networking*) yang dibentuk oleh PT. Nayaka Era Husada dan ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
5. **Peserta program JPK Tambahan** adalah pegawai PT. BPJS Ketenagakerjaan, pensiunan dan keluarga, anak maksimal 3 (tiga) orang belum menikah serta maksimal usia 25 Thn, dan Peserta JPK Nayaka adalah tenaga kerja serta keluarganya yang telah didaftarkan dan dibayarkan preminya oleh perusahaan untuk mengikuti Program JPK Nayaka;
6. **Perusahan** adalah badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara;
7. **Kartu Peserta Nayaka (KPN)** adalah kartu tanda kepesertaan Program **JPK Nayaka dan JPK Tambahan** yang diterbitkan oleh PT. Nayaka Era Husada untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada jaringan (*networking*) Pelaksana Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk;



Paraf PIHAK PERTAMA

Halaman 2 dari 23



Paraf PIHAK KEDUA

8. **Formularium Nasional** adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional;
9. **Daftar obat Standar JPK Tambahan** adalah daftar obat-obatan yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dan **Daftar obat Standar JPK Nayaka** adalah daftar obat-obatan yang dikeluarkan PT. Nayaka Era Husada, daftar obat tersebut pemilihannya didasarkan pada obat esensial nasional (DOEN) terdiri dari obat generik dan obat merk dagang yang dapat diberikan oleh PPK tingkat I dan PPK tingkat II kepada peserta sesuai kebutuhan medis;
10. **Emergensi** adalah suatu kondisi kesehatan yang memerlukan tindakan atau pertolongan medis segera dan apabila tidak dilakukan akan berakibat fatal dan dapat menyebabkan kematian;
11. **Mal Praktek** adalah pelayanan medis yang tidak profesional, tidak kompeten dan tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, tindakan tersebut dapat berupa tindakan dokter, pemberian obat-obatan, penunjang medis / diagnostik maupun terapi lainnya dan sebagai akibatnya bisa menimbulkan kerusakan fisik maupun mental, kematian dan kerugian finansial;
12. **COB** adalah suatu metode dimana dua atau lebih penanggung (insurer) yang menanggung orang yang sama untuk benefit asuransi kesehatan yang sama, untuk mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan tidak melebihi 100% dari realisasi biaya kesehatan;
13. **SURAT JAWABAN KONSULTASI** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter PIHAK PERTAMA yang berbentuk resume medik peserta selama perawatan/mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hanya diberikan kepada PIHAK KEDUA yang mengeluarkan surat pengantar dan / atau surat jaminan pembayaran;
14. **SURAT JAMINAN** adalah surat jaminan atas biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
15. **Kartu Peserta BPJS Kesehatan** adalah kartu yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan sebagai bukti kepesertaan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan;
16. **Peserta COB** adalah peserta yang memiliki kartu pelayanan kesehatan dan kartu peserta BPJS yang digunakan saat mendapatkan pelayanan kesehatan;
17. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Faskes oleh petugas verifikator BPJS center Rumah Sakit.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia dalam batas-batas fasilitas yang ada dalam lingkungan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta **PIHAK KEDUA**, yaitu :

B. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

1. Administrasi pelayanan; meliputi biaya pendaftaran peserta untuk berobat, penerbitan surat eligibilitas peserta, pembuatan kartu pasien dan

			
---	---	---	---

Paraf PIHAK PERTAMA

			
---	---	---	---

Paraf PIHAK KEDUA

- biaya administrasi lain yang terjadi selama proses perawatan atau pelayanan kesehatan pasien;
2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialis oleh dokter spesialis dan subspesialis termasuk pelayanan kedaruratan;
 3. Tindakan medis spesialis baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 6. Pelayanan darah;
 7. Rujukan Internal.

C. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

Ruang lingkup pelayanan kesehatan RITL adalah sesuai dengan seluruh cakupan pelayanan di RITL dengan tambahan akomodasi yaitu:

1. Perawatan inap non intensif;
2. Perawatan inap intensif.

D. Pelayanan Persalinan

1. Tindakan persalinan normal;
2. Tindakan persalinan dengan penyulit per vaginam sesuai indikasi medis;
3. Tindakan persalinan dengan penyulit perabdominam (*sectio caesaria*) sesuai indikasi medis.

E. Pelayanan Gawat Darurat

1. Pelayanan gawat darurat yang dapat dijamin adalah sesuai dengan kriteria gawat darurat yang berlaku sebagaimana terlampir;
2. Cakupan pelayanan gawat darurat sesuai dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.

F. Pelayanan Obat

1. Pemberian obat untuk pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) berdasarkan resep obat dari dokter umum, dokter spesialis / subspesialis yang merawat, berpedoman pada Formularium Nasional (FORNAS) yang sesuai dengan indikasi medis;
 2. Pada Faskes rujukan tingkat lanjutan jika obat yang diberikan tidak tercantum dalam FORNAS dapat digunakan Formularium JPK Tambahan / JPK Nayaka;
 3. Bila obat yang diberikan oleh dokter adalah diluar standar obat JPK Tambahan / JPK Nayaka dan peserta tidak ingin diganti dengan obat standar JPK Tambahan / JPK Nayaka yang sama, maka peserta harus membayar selisih biaya obat;
 4. Dalam hal pemilihan obat karena permintaan Peserta maka menjadi tanggung jawab Peserta.
2. Pemberian Pelayanan kesehatan bagi Peserta COB BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan surat rujukan dari FKTP BPJS Kesehatan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Medis dan

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

Etika Kedokteran serta Prosedur Pelayanan Rumah Sakit kecuali untuk kasus gawat darurat.

PASAL 3 PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

- a. Peserta membawa 2 (dua) kartu yaitu kartu BPJS Kesehatan dan kartu peserta Nayaka untuk eligibilitas peserta;
- b. Peserta membawa surat rujukan dari FKTP BPJS Kesehatan;
- c. **PIHAK PERTAMA** memeriksa keabsahan kartu peserta perusahaan, kartu BPJS Kesehatan, surat rujukan dan melakukan entry data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP);
- d. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pencetakan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan berlaku;
- e. Apabila peserta tidak membawa kartu dan atau surat rujukan maka diberlakukan sebagai pasien umum, maka akibat dan kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan kecuali dalam hal pelayanan kesehatan kegawatdaruratan.

2. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)

- a. Merupakan tindak lanjut dari Unit Gawat Darurat, dan klinik Rawat Jalan Tingkat Lanjutan;
- b. Peserta membawa 2 (dua) kartu yaitu kartu BPJS Kesehatan dan kartu peserta Nayaka untuk eligibilitas peserta;
- c. Peserta membawa surat pengantar rawat Inap untuk memperoleh surat jaminan dari BPJS Kesehatan;
- d. **PIHAK PERTAMA** menerima dokumen administrasi peserta untuk mendapatkan pelayanan rawat inap;
- e. Peserta akan ditempatkan pada kelas perawatan sesuai dengan hak kelas pasien BPJS Kesehatan yang tercantum dalam SJP;
- f. Peserta dapat dirawat satu tingkat diatas hak kelas perawatan jaminan BPJS Kesehatan kecuali untuk pensiunan (Emerald) setinggi-tingginya dijamin di kelas 1 (satu);
- g. Apabila peserta menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dari hak kelas *Top Up* -nya maka, peserta diwajibkan membuat surat pernyataan dan selisih biaya sesuai haknya menjadi tanggung jawab peserta dan dibayar pada saat dinyatakan diperbolehkan pulang;
- h. Peserta harus melengkapi persyaratan administrasi maksimal 2 x 24 jam hari kerja sejak masuk rawat inap di fasilitas kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
- i. Apabila peserta dalam kurun waktu 2 x 24 jam tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi rawat inap sebagai pasien program Top Up BPJS Kesehatan maka diberlakukan sebagai pasien umum, kewajiban yang timbul seluruhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- j. Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak kelas peserta tidak tersedia atau penuh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari **PIHAK PERTAMA**, maka peserta ditempatkan 1 kelas lebih tinggi dari hak rawatnya, dalam waktu maksimal 3 x 24 jam. **PIHAK PERTAMA** akan menempatkan peserta pada kelas

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

- yang menjadi haknya dan selisih biaya yang timbul akibat kenaikan kelas menjadi tanggungan PIHAK KEDUA (tarif kesepakatan kelas perawatan murni yang ditempati dikurangi hak rawat tarif Ina CBGs);
- k. Apabila peserta memerlukan jenis pemeriksaan yang tidak tersedia di **PIHAK PERTAMA** maka dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain yang lebih lengkap atas persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- l. **PIHAK PERTAMA** menagihkan klaim menggunakan sistem paket INA-CBGs kepada BPJS Kesehatan;
- m. Apabila terdapat selisih atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah mendapat jaminan dari **PIHAK KEDUA** maka, selisih biaya akan ditagihkan kepada **PIHAK KEDUA**.

3. Pelayanan Gawat Darurat

Dalam keadaan gawat darurat, maka:

- a. Pelayanan harus segera diberikan pertolongan sesuai dengan kasus tanpa diperlukan surat rujukan. Peserta dapat langsung ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** melalui Unit Gawat Darurat (UGD);
- b. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengecekan validitas kartu kepesertaan perusahaan dan BPJS Kesehatan dan apabila peserta **PIHAK KEDUA** tidak membawa kartu peserta, maka PIHAK PERTAMA dapat berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**;
- c. Peserta yang datang berobat ke UGD dilakukan pemeriksaan awal, apabila ditemukan tidak termasuk kriteria gawat darurat maka akan diberlakukan penjaminan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA**

- a. Memperoleh informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan dan mekanisme kerjasama;
- b. Menerima pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang disepakati **PARA PIHAK**;
- c. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini;
- d. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Melayani Peserta dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran, prosedur pelayanan kesehatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Menyediakan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK PERTAMA** dan informasi lain tentang pelayanan kepada

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

Halaman 6 dari 23

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. Menyediakan petugas sebagai tenaga informasi dan penanganan keluhan terkait dengan pelayanan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menyediakan petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan keabsahan kartu dan surat rujukan serta melakukan entry data ke dalam aplikasi Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan melakukan pencetakan SEP;
- e. Mengajukan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta secara periodik kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. Menanggung semua biaya pelayanan kesehatan atas kelalaian/Mal Praktek yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada peserta (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh **PIHAK KEDUA** yang didasarkan pada persetujuan umum (*General Consent*) yang salah satunya berisi persetujuan pasien untuk melepaskan informasi kepada pembayar;
- d. Memberikan teguran dan atau peringatan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini;
- e. Meninjau kembali Perjanjian ini apabila **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan tanggapan terhadap peringatan tertulis.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan dan memberikan informasi tentang kepesertaan, ruang lingkup, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan dan mekanisme kerja sama pada **PIHAK PERTAMA**;
- b. Membayar biaya atas pelayanan kesehatan peserta yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai tagihan yang diajukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
- c. Membayar biaya pelayanan kesehatan sebagaimana huruf b, secara tepat waktu untuk menjaga likuiditas **PIHAK PERTAMA**;
- d. Melaksanakan proses evaluasi dan penilaian secara berkala atas kesiapan **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi Faskes tingkat lanjutan dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- e. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA**, melakukan sosialisasi prosedur pelayanan, tata cara pengajuan klaim, kepada pihak yang berkepentingan;
- f. Menyimpan rahasia informasi pasien yang digunakan untuk proses pembayaran klaim.

--	--	--	--	--

Paraf **PIHAK PERTAMA**

--	--	--	--	--

Paraf **PIHAK KEDUA**

PASAL 5
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit dari **PIHAK PERTAMA** ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**;
2. Tarif Ina CBGs sesuai dengan ketentuan BPJS Kesehatan;
3. Dalam hal terjadi penyesuaian tarif pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan hal tersebut kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum penyesuaian tersebut diberlakukan;
4. Penetapan harga jual apotek (HJA) = HNA X Ppn X 1,25;
5. Biaya yang di tagihkan kepada **PIHAK KEDUA** adalah
 - a. biaya tarif kesepakatan antara **PARA PIHAK** dikurangi dengan biaya INACBG's bila kenaikan dari kelas 2 BPJS Kesehatan ke kelas 1
 - b. biaya maksimal 75% dari coding Ina CBGs bila kenaikan dari kelas 1 BPJS Kesehatan ke kelas VIP.

PASAL 6
PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Pengajuan klaim pelayanan kesehatan untuk pasien dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** secara kolektif setiap bulan, atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta;
2. Tagihan atas selisih biaya pelayanan kesehatan diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum proses verifikasi selesai dari BPJS Kesehatan. Rekonsiliasi akan dilakukan setelah proses verifikasi oleh BPJS selesai;
3. Penagihan atas selisih biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas dilengkapi dokumen penagihan berupa :
 - a. Surat permintaan pembayaran dengan mencantumkan Nomor PKS, dan alamat transfer (Nama, Nama Bank, No.Rekening Bank) sebagaimana tersebut dalam ayat (8) pasal ini;
 - b. Kuitansi rangkap 3 (tiga) yang dibubuhi materai secukupnya (1 lembar asli, dan 2 lembar foto copy kuitansi);
 - c. Surat pengantar berobat dan / resume medis sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Rekapitulasi / faktur penagihan rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dalam rangkap 3 (tiga) dengan memisahkan antara biaya rawat inap dan rawat jalan.
4. Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** terhadap penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima dan dinyatakan benar, lengkap, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar oleh **PIHAK KEDUA**;
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman penagihan dari **PIHAK PERTAMA** tidak ada sanggahan ataupun tanggapan dari **PIHAK KEDUA**, maka penagihan tersebut dianggap sudah lengkap dan benar;
6. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu ≥ 60 hari setelah tagihan dikirim tanpa pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** akan memberlakukan peserta **PIHAK KEDUA** sebagai pasien umum dan dikenakan denda sebesar 2% dari nominal tagihan. Denda berlaku kelipatan sesuai dengan jumlah bulan keterlambatan pelunasan;

--	--	--	--	--

Paraf **PIHAK PERTAMA**

Halaman 8 dari 23

--	--	--	--	--

Paraf **PIHAK KEDUA**

7. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara giral dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA;
8. Transfer atas pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (7) pasal ini akan dialamatkan kepada :

RS PRIMA HUSADA MALANG

Nama Penerima : PT DISA PRIMA MEDIKA
 Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk
 Cabang, Alamat : KK Malang Singosari, Jl Raya Singosari No. 93, Lsari Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65153
 Nomor Rekening : 368-3040700
 Kode Swift / IBAN : CENAIDJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Nama Penerima : PT DISA PRIMA MEDIKA
 Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
 Cabang, Alamat : KK Malang Sutoyo, Jl. Letjen Sutoyo No. 18-20, Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 35141
 Nomor Rekening : 144-0055533324
 Kode Swift / IBAN : BMRIIDJA

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

1. Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui email, ekspedisi, pos atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA,

Perseroan : PT. Disa Prima Medika
Alamat : PERUM BANJARARUM SELATAN 3 B RT 003 RW 012
 BANJARARUM SINGOSARI KABUPATEN MALANG
No Telp : 0341-458679
No. Fax : -

RS Prima Husada Malang

Bagian	Person In Charge (PIC)	Keterangan
Marketing	Nama : Mayputri Nabilla A.Md.Kes Telp : 081-135-071-64 Email : marketingrsphm@gmail.com	
Pelayanan Medis	Nama : Daning Pravitia Telp : 0811-3110-3113 Email : marketing@malang.rs-primahusada.com	



Paraf PIHAK PERTAMA

Halaman 9 dari 23

Paraf PIHAK KEDUA

Admin	Nama : Lilik Kurniati	
Tagihan dan	Telp : 081331429720	
Pembayaran	Email : admklaim.rsph@gmail.com	

RS Prima Husada Sukorejo

Bagian	Person In Charge (PIC)	Keterangan
Marketing	Nama : Anita Fitriarsi, S.E Telp : 0813-1557-4065 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com	
Pelayanan Medis	Nama : Nur Aini Izzah, S.Kep., Ns Telp : 0811 3031 885 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com	
Admin Tagihan dan Pembayaran	Nama : Prisna Sandy Faradilla Telp : 0821 4203 6398 Email : keuanganrsphs@gmail.com	

PIHAK KEDUA :

Nama Perusahaan : PT. Nayaka Era Husada Cabang Malang
 Alamat : Jl.Ciujung no 4 Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Malang
 Telepon : 0341-477805
 Faksimili : 0341-402099
 Email : neh_malang@yahoo.co.id

Pejabat yang ditunjuk :

Nama : Velinda Dwi K., S.Kep. Ns
 Jabatan : Manager Pelayanan & Provider PPK II
 Telepon : 081358288202
 Faksimili :
 E-mail : velindadk@yahoo.co.id

Tanda tangan :

Nama : Amalia Istiqomah, SE
 Jabatan : Manager Keuangan & Umum
 Telepon : 081334682557
 Faksimili :
 E-mail : amalia_istiqomah84@yahoo.co.id

Tanda tangan :

Nama : Ambar Kristina
 Jabatan : Manager Pemasaran & Provider PPK I
 Telepon : 083830160239
 Faksimili : -

 Paraf PIHAK PERTAMA

 Paraf PIHAK KEDUA

E-mail : ambarkristina_lim@yahoo.co.id

Tanda tangan :



2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melaluifaksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 30-05-2025 sampai dengan tanggal 30-05-2028 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Jika satu dari KEDUA BELAH PIHAK ingin mengakhiri perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu tidak kurang dari 1 (satu) bulan sebelum keputusan perjanjian tersebut berlaku.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir;
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab Pihak yang lain.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 11 SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melayani Peserta sesuai dengan kewajibannya;
 - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan hak peserta;
 - c. Melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak melakukan teguran tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. **PARA PIHAK** berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK LAINNYA** berkenaan dengan teguran atas pelanggaran yang dilakukan;
3. Dalam hal salah satu pihak diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau *fraud* seperti membuat klaim fiktif yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Internal maupun Eksternal sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 12 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran / peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran / peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

Halaman 12 dari 23

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;

- c. Ijin usaha atau operasional salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak yang bersangkutan oleh Pemerintah;
 - d. Salah satu Pihak melakukan merger, konsolidasi, atau diakuisisi oleh perusahaan lain. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan; dan
 - f. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan di likuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
2. Dalam hal **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
 3. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim / Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan / mengakhiri suatu Perjanjian.
 4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

PASAL 13 **PERUBAHAN ATAS KETENTUAN BPJS**

Dalam hal terjadi perubahan atas ketentuan BPJS terhadap kepesertaan COB atau aturan BPJS lainnya yang sifatnya mengikat para pihak maka para pihak wajib untuk mengikuti atas perubahan tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

PASAL 14 **AMANDEMEN**

Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan/penambahan klausul yang bersifat prinsip / material, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan pihak lainnya, untuk kemudian dituangkan dalam bentuk *Amandemen* / Addendum.

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 15 PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum / Amandemen* serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini;
2. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan KEDUA BELAH PIHAK, 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar asli untuk PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
PT. Disa Prima Medika



PT. DISA PRIMA MEDIKA

 **dr. Sefrina Trisadi, Sp. Dv**
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT. Nayaka Era Husada Branch Malang



Apt. Sri Suntari, S.Si
Branch Manager

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

LAMPIRAN I
PELAYANAN PRIVILEGE

1. Pelayanan privilege adalah Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) tanpa menggunakan rujukan dari FKTP BPJS Kesehatan;
2. Pelayanan Privilege yaitu:
 - a. Spesialis Anak (usia anak sampai dengan 12 tahun, kecuali layanan gigi);
 - b. Spesialis Kebidanan (Obstgyn);
 - c. Spesialis Mata;
 - d. Spesialis THT.

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

LAMPIRAN II KETENTUAN TAMBAHAN

1. USG yang di tanggung hanya USG 2 dimensi;
2. Tindakan Laparascopi hanya untuk kasus batu empedu;
3. Peserta dapat dilayani oleh Dokter Sub Spesialis atas rujukan dari Dokter Spesialis ;
4. Tindakan gigi yang dapat dilakukan pada RS hanya untuk kasus: odontectomy dan tindakan gigi lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh dokter gigi;
5. Obat - obatan sesuai dengan kebutuhan medis (kecuali yang diberikan parenteral seperti Albumin, Dopamin, golongan Cephalosporin, Quinolon dan sejenisnya) diberikan dengan konfirmasi terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**. Obat – obatan **Rawat jalan** dengan harga diatas **Rp.500.000,-**(Lima ratus ribu rupiah) dan obat-obatan **Rawat inap** diatas **Rp.1.000.000,-**(satu juta rupiah) untuk satu jenis obat (satu R/) diberikan dengan **legalisasi** dari **PIHAK KEDUA**;
6. Pemeriksaan TORCH dapat dilakukan bila ada indikasi medis;
7. Untuk pemeriksaan canggih dengan surat jaminan, harus melalui pemeriksaan berjenjang terlebih dahulu. (Contohnya Pemeriksaan Radiologi, CT-Scan, MRI dan Pemeriksaan Canggih lainnya yang menggunakan surat jaminan).

	[Signature]	[Signature]	
--	-------------	-------------	--

Paraf PIHAK PERTAMA

[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
-------------	-------------	-------------	-------------

Paraf PIHAK KEDUA

LAMPIRAN III
HAL – HAL YANG TIDAK DI TANGGUNG

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar PPK yang disediakan dan atau tidak melalui prosedur yang berlaku sedangkan penderita tidak mengalami gawat darurat, tidak sedang berada diluar kota atau di luar negeri, bukan persalinan dan pelayanan khusus;
2. General Check-Up atas kehendak sendiri;
3. Penyakit akibat alkohol dan narkotik;
4. Penyakit akibat hubungan kerja / kecelakaan kerja;
5. Penyakit / cidera akibat kesengajaan seperti usaha bunuh diri;
6. Penyakit atau cidera akibat olah raga berbahaya;
7. Penyakit atau cidera akibat perbuatan melawan hukum;
8. Obat dan vitamin tidak ada kaitannya dengan indikasi medis dan atau atas kehendak sendiri;
9. Persalinan anak ke-4 (empat) dan seterusnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan tersebut;
10. Abortus tanpa indikasi medis termasuk kesengajaan;
11. Tindakan / perawatan dan obat-obatan kosmetik atau kecantikan;
12. Tindakan dan obat-obatan untuk memperoleh kesuburan / keturunan;
13. Obat gosok / tempel seperti : minyak kayu putih, koyo dan sejenisnya;
14. Alat perawatan kesehatan seperti : termometer, eskap dan sejenisnya;
15. Semua biaya pengangkutan;
16. Seluruh biaya pelayanan kesehatan diatas plafond (waktu, fasilitas, biaya);
17. Pengobatan alternatif seperti dukun patah tulang dll;
18. BPJS Ketenagakerjaan tidak menanggung biaya perawatan apabila perawatan kesehatan karyawan sudah mendapatkan penggantian dari perusahaan atau instansi lain, namun akan menanggung selisih biaya perawatan yang tidak mendapatkan penggantian dari Perusahaan atau instansi tersebut.

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

LAMPIRAN IV HAK KELAS PERAWATAN

Ketentuan Rawat Inap Peserta JPK Plus :

1. Bila tidak menggunakan prosedur BPJS Kesehatan, Standar rawat inap dibagi menjadi 2 (dua) tingkatan (kelas perawatan) yaitu :
 - a. Karyawan yang menduduki Grade 18 sampai dengan 12 beserta anggota keluarga di kelas I Rumah Sakit Swasta/ BUMN/ ABRI dan di kelas VIP Rumah Sakit Pemerintah Pusat/ Daerah.
 - b. Pensiunan yang semasa menjadi Karyawan aktif menduduki Grade 1a atau 18 sampai dengan 2c atau 12 di kelas I Rumah Sakit Swasta/ BUMN/ ABRI dan di kelas VIP Rumah Sakit Pemerintah Pusat/ Daerah, sedangkan anggota keluarganya di kelas II Rumah Sakit Swasta / BUMN / ABRI dan kelas I Rumah Sakit Pemerintah Pusat/ Daerah.
 - c. Karyawan dan Pensiunan yang semasa menjadi Karyawan aktif menduduki Grade 3a atau 11 sampai dengan 6c atau 1 beserta anggota keluarga di kelas II Rumah Sakit Swasta / BUMN / ABRI dan kelas I Rumah Sakit Pemerintah Pusat/ Daerah.

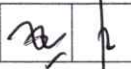
Tanpa Optimalisasi/ COB BPJS Kesehatan

No	Karyawan/ Pensiunan	Kelas Rawat Inap	
		RS. Pemerintah	RS. Swasta
1.	Karyawan Aktif beserta keluarga dan Pensiunan hanya tenaga kerja Grade 12 s/d 18	VIP	I
2.	Karyawan Aktif dan Pensiunan beserta keluarga Grade 1 s/d 11	I	II

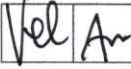
2. Bila menggunakan Prosedur BPJS Kesehatan, Standar rawat inap dibagi menjadi :
 - a. Pemegang kartu Diamond hak kelas rawat inap kelas VVIP.
 - b. Pemegang kartu Gold hak kelas rawat inap kelas VIP Plus
 - c. Pemegang kartu Shapire hak kelas rawat inap kelas VIP
 - d. Pemegang kartu Emerald hak kelas rawat inap setinggi – tingginya kelas 1

Kelas rawat inap Optimalisasi/ COB bagi peserta yang telah dijamin (Penjamin Pertama) BPJS Kesehatan sebagai berikut :

No	Karyawan/ Pensiunan	Kelas Rawat Inap	
		BPJS Kesehatan	OPTIMALISASI/ COB NAYAKA
1.	Direksi dan Dewan Pengawas	I	V.VIP/ Super VIP
2.	Karyawan Aktif Grade 17, 18	I	VIP/ VIP Plus
3.	Karyawan Aktif Grade 1-	I	VIP



Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA

	16		
4.	Pensiunan Karyawan	II	I

3. Jumlah hari Rawat Inap berikut obat-obatan, penunjang diagnostik dan alat-alat kesehatan termasuk perawatan ICU/ ICCU untuk setiap jenis penyakit dalam 1 (satu) tahun kalender adalah berdasarkan indikasi medis yang dibuktikan dari rekam medis dan tanpa batas waktu.
4. Apabila peserta di rawat inap pada kelas yang lebih rendah dari yang sudah ditentukan, maka besarnya biaya rawat inap disesuaikan dengan tarif Rumah Sakit yang berlaku untuk kelas tersebut, bila rawat inap di Rumah Sakit yang sudah ditentukan masih penuh, maka peserta dapat dipindah ke Rumah Sakit Rujukan lainnya.

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

LAMPIRAN V
DAFTAR FORMULARIUM

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

LAMPIRAN VI
DAFTAR TARIF

(dilampirkan terpisah)

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA

LAMPIRAN VII COORDINATION OF BENEFIT

1. Peserta dijamin apabila sesuai dengan prosedur COB.
2. BPJS Kesehatan sebagai penjamin pertama dan **PIHAK KEDUA** sebagai penjamin kedua.
3. BPJS Kesehatan menjamin biaya Pelayanan Kesehatan sesuai tarif yang berlaku pada program Jaminan Kesehatan Nasional dan selisihnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. Pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional seluruhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sesuai batasan manfaat yang tertuang dalam perjanjian.
5. Skema penagihan dari **PIHAK PERTAMA** :

(1) **Rawat Jalan**

- a. Rincian biaya/tarif sesuai dengan tarif kesepakatan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- b. Penagihan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan Coding InaCBG's (versi **PIHAK PERTAMA**);
- c. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan ke **PIHAK KEDUA** sesuai dengan selisih dari tarif kesepakatan (real cost) dikurangi tarif InaCBG's dikurangi biaya/tarif yang menjadi beban Peserta bila kenaikan dari kelas 2 BPJS Kesehatan ke kelas 1 dan maksimal 75 % dari tarif InaCBG's bila kenaikan dari kelas 1 BPJS Kesehatan ke kelas VIP;
- d. BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap tagihan **PIHAK PERTAMA** atas Peserta;
- e. Setelah **PIHAK PERTAMA** menerima hasil verifikasi BPJS Kesehatan dan terdapat selisih atas tagihan tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan konversi tagihan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **Rawat Inap**

- a. Rincian biaya/tarif sesuai dengan tarif kesepakatan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- b. Penagihan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan hak rawat kelas BPJS dan Coding InaCBG's (versi **PIHAK PERTAMA**);
- c. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penagihan ke **PIHAK KEDUA** sesuai dengan selisih dari tarif kesepakatan (real cost) dikurangi tarif InaCBG's dikurangi biaya/tarif yang menjadi beban Peserta bila kenaikan dari kelas 2 BPJS Kesehatan ke kelas 1 dan maksimal 75 % dari tarif InaCBG's bila kenaikan dari kelas 1 BPJS Kesehatan ke kelas VIP;
- d. BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap tagihan **PIHAK PERTAMA** atas Peserta;

--	--	--	--	--

Paraf **PIHAK PERTAMA**

--	--	--	--	--

Paraf **PIHAK KEDUA**

- e. Setelah **PIHAK PERTAMA** menerima hasil verifikasi BPJS Kesehatan dan terdapat selisih atas tagihan tersebut, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan konversi tagihan kepada **PIHAK KEDUA**.

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA